

Trauma *zdrady*

Reakcja partnera/-ki nie jest „przesadą”. To prawdziwa trauma — często z objawami PTSD. Zrozumienie tej traumy jest pierwszym krokiem do nie-pogłębiania jej.

CZAS: 30 min czytania Po ujawnieniu

ŹRÓDŁO: Steffens & Rennie (2006); Manning (2006); Schneider (2017)

JAK UŻYWAĆ

Karta dla pacjenta z PPU — by zrozumieć **co dzieje się u partnera/-ki** po odkryciu PPU. Steffens & Rennie (2006) udokumentowali, że reakcje partnerów/-ek mają wszystkie cechy **traumy**: 1) flashbacki, 2) hiperczułość, 3) unikanie, 4) zaburzenia snu, 5) zmiany w postrzeganiu siebie, świata, relacji. Karta przedstawia: 1) *4 fazy reakcji* partnera/-ki, 2) *co nie mówić i robić*, 3) *co pomaga*, 4) długoterminowa praca nad ufnością.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjent z PPU często *nie rozumie* reakcji partnera/-ki: „*to tylko porno, nie zdradziłem fizycznie*”. Z perspektywy partnera/-ki to jest **zdrada** — utrata zaufania, podważenie podstaw związku. Manning (2006, n=100 par) wykazała, że **70% partnerek** pacjentów z PPU spełnia kryteria PTSD w ciągu pierwszych 6 miesięcy po ujawnieniu. To nie jest „przesada” — to jest *realny zespół traumy*. Bez zrozumienia tego, pacjent z PPU często *pogłębia traumę* przez bagatelizowanie („*przesadzasz*”), defensywność („*czemu nie ufasz mi już teraz*”), naciskanie na powrót do „normalności”. Karta uczy *nie pogłębiać*, by druga osoba mogła leczyć się.

01 = Cztery fazy traumy zdrady

1 · SZOK (DNI 1–7)

Niedowierzenie, dysocjacja, „*to nie może być prawda*”. Funkcjonowanie obniżone. Trudności ze snem, jedzeniem. Płacz, krzyk lub odrętwienie.

2 · HIPERCZUJNOŚĆ (TYGODNIE 1–8)

Sprawdzanie telefonu, historii, rachunków, terminów. Pytania ciągłe. Nie ufa Twoim słowom. Czujność jak po wypadku samochodowym — układ nerwowy w stanie alarmu.

3 · REAKCJE EMOCJONALNE (MIES. 1–6)

Wahania: gniew, smutek, lęk, obwinianie siebie, kwestionowanie wszystkiego. „*Czy byłam dobra wystarczająco?*” — fałszywa odpowiedzialność. Częste pytania o szczegóły.

4 · INTEGRACJA (MIES. 6–24)

Powolna stabilizacja. Zaczyna decydować: zostaje czy odchodzi. Buduje nowy obraz Ciebie. Wraca do swojej tożsamości. Wymaga 1–2 lat na pełną integrację.

02 ✗ Czego NIE robić

Bagatelizować — „*to tylko porno*”. Dla niej to nie „tylko”.

Naciskać na seks — to retraumatyzuje. Daj jej decyzję.

Bronić się z gniewem na jej hiperczułość. To trauma, nie kontrola.

Dawać limit czasowy — „*kiedy mi wreszcie zaufasz*”. Trauma trwa, ile trwa.

Pytać „nie wybaczasz?” — przebaczenie jest jej procesem, nie Twoim prawem.

Obciążać dzieci — żadnego mówienia im, prośby o jej „obronę”.

1 • KONSEKWENTNA JAWNOŚĆ

Pełen dostęp do urzędzeń, raporty z terapii, brak ukrywania. Hiperczułość maleje, gdy nie ma czego ukrywać.

2 • EMPATIA BEZ BRONIENTA SIĘ

„Wiem, że to bolało. Rozumiem, że teraz nie ufasz. Nie spodziewam się szybkiego powrotu zaufania.”

3 • JEJ WŁASNY TERAPEUTA

Nie ten sam co Twój. Zachęcaj ją do terapii indywidualnej. Polecaj specjalistów od „*betrayal trauma*”.

4 • TERAPIA PARY — PÓŹNIEJ

Nie od razu. Po 3–6 mies. indywidualnej pracy obojga. Terapia pary za wcześnie może retraumatyzować.

5 • CZAS + CIERPLIWOŚĆ

Pełne odzyskanie zaufania trwa 2–5 lat. Nie 6 miesięcy. Akceptuj rytm, nie przyspieszaj.

6 • MAŁE DOWODY

Codziennie, drobne pokazy uważności i odpowiedzialności. *„Pojadę po pieczywo, wracam o 18:30”*. Dotrzymywanie. Buduje od dna.

CO ROBIĘ REGULARNIE, BY WSPIERAĆ JEJ PROCES

— konkretne małe zachowania

CZEGO UNIKAM

— moje czerwone linie

Klucz: Schneider (2017, podsumowanie 30 lat pracy klinicznej) podkreśla, że **partner/partnerka pacjenta z PPU nie potrzebuje rozumienia mechanizmów PPU** w pierwszych miesiącach — potrzebuje *uznania* swojej traumy. Pacjent, który próbuje „*edukować*” partnerkę o neurobiologii uzależnienia, dopaminie itp. — często zwiększa ranę. Najważniejsze: *„Twoja reakcja jest uzasadniona. Twoja trauma jest realna. Nie spodziewam się szybkiego powrotu do normalności.”* Z tej bazy może zacząć się leczenie. Bez niej — każda inna interwencja wisi w próżni.